分子线 档案 B · 家属代记视角 | 图谱 CML-MOL | 记录者随条目标注

趋势与词表 | 指标卡（分系列·翻面） | 复查记录 CML-LAB（二级）

状态与缩放

有数据 | 空态 | 单点 | 错误态（拒收候选）

时间范围（缩放）：**全部** | 近 12 个月 | 近 6 个月 | 近 3 个月

纵轴刻度：**线性（按值）** | 对数

指标（多选 ≤4）：**BCR::ABL1（IS%）** | 白细胞 | 中性粒细胞 | 血红蛋白 | 血小板 | 副作用记录 | 月自费金额

分类值（kind=qual/grade，如副作用记录）不进曲线，只在下方按事件列出。

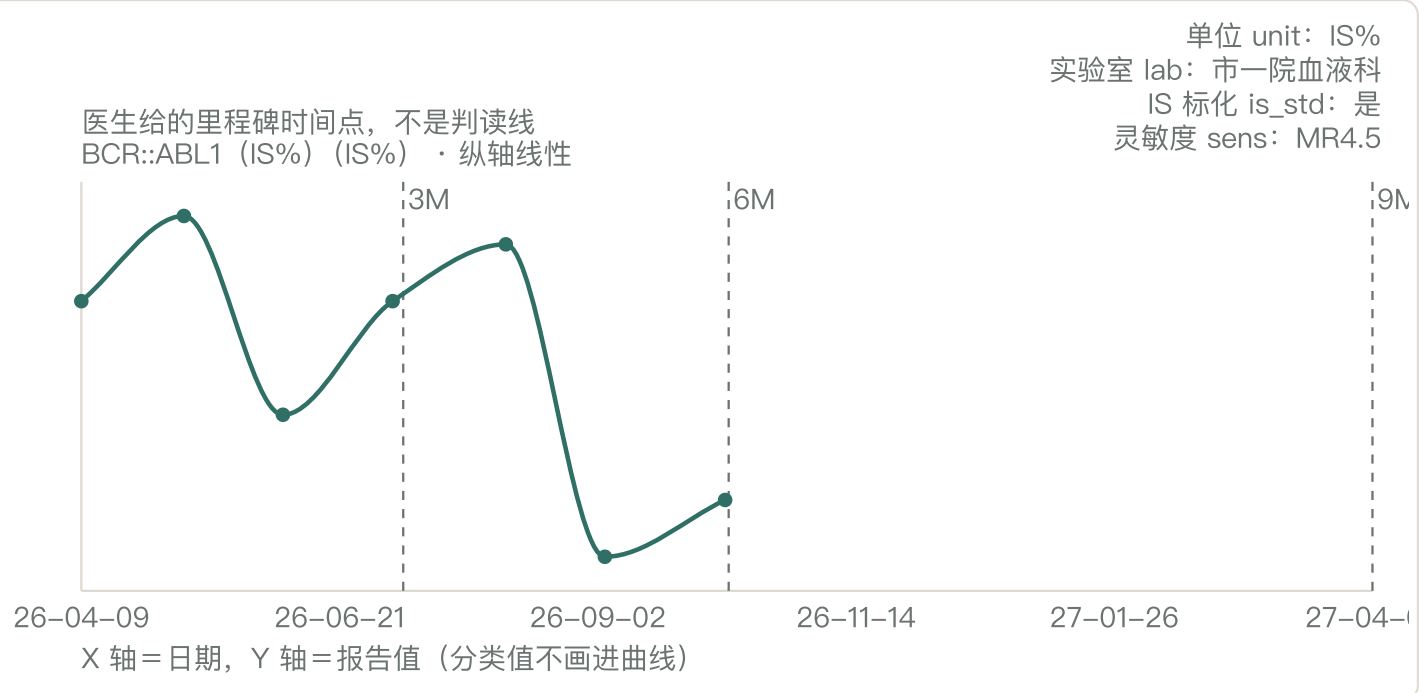
趋势

SVG class="chart" | Fritsch–Carlson 单调三次插值

里程碑角标（点开看词义与来源版本）：IS% | MMR | MR4 | MR4.5 | CMR / DMR | 临床研究核对字段

资料导入（候选 → 核对）

BCR::ABL1（IS%）（IS%）



单位：IS%　纵轴：线性　参考线：3 / 6 / 12 月（灰虚线）　参考线含义：医生给的里程碑时间点，不是判读线

口径：数值只抄报告原文；不同实验室/未 IS 标化不可直接连成一条线（趋势页会分段）

> 引指南口径（来源：中国 CML 诊疗指南 2025 版）：“不建议根据 BCR::ABL1 IS 的单次、单一数值做出转换治疗的决策”
> 来源：中国 CML 诊疗指南（2025 版）· 分子学监测章节

实验室与可比性（HVT-07 四要素）

unit / lab / is_std / sens

日期	值	单位 unit	实验室 lab	IS 标化 is_std	灵敏度 sens	来源	记录者
2026-04-09	0.003	IS%	市一院血液科	是	MR4.5	停药前最后 1 次	记录者：家属代记
2026-05-08	0.003	IS%	市一院血液科	是	MR4.5	停药后 1 个月	记录者：家属代记
2026-06-05	0.002	IS%	市一院血液科	是	MR4.5	停药后 2 个月	记录者：家属代记
2026-07-06	0.003	IS%	市一院血液科	是	MR4.5	停药后 3 个月	记录者：家属代记
2026-08-07	0.003	IS%	市一院血液科	是	MR4.5	停药后 4 个月	记录者：家属代记
2026-09-04	0.002	IS%	市一院血液科	是	MR4.5	停药后 5 个月	记录者：家属代记
2026-10-08	0.002	IS%	市一院血液科	是	MR4.5	停药后 6 个月	记录者：家属代记

> 相邻两点「实验室不同」或「IS 标化不为 1」→ 图上断开折线并标注「不可比（实验室/标化不同）」。任一要素缺失时显示「未记录」。

可比性演示：把最近一点按「外院 / 未 IS 标化」渲染　仅视图层演示，不改动 demo-data.js

词表（HVT-01 转录本 / HVT-02 分期 / 里程碑）

转录本类型	口径原文	本档案	来源
e13a2（典型）	BCR 外显子 13 与 ABL1 外显子 2 融合	本档案	血液科 2020-03-11 RT-PCR
e14a2（典型）	BCR 外显子 14 与 ABL1 外显子 2 融合	—	血液科 2020-03-11 RT-PCR
非典型转录本	需高标准实验室定量（阈值口径照抄报告）	—	中国 CML 诊疗指南（2025 版）

分期	原始阈值口径	来源版本
CP 慢性期	原始细胞（骨髓/外周血）<10%，无 AP/BP 特征	ICC2022
AP 加速期	原始细胞 10–19%，或出现指定额外染色体发现（ACA）等口径	ICC2022
BP 急变期	原始细胞 ≥20%（髓系/淋系/双表型按报告原文）	ICC2022

> 分期词表只放阈值与版本，不出现「你属于哪期」这类结论。

里程碑词	报告里怎么写	口径原文（照抄）	来源版本
CMR / DMR	完全分子学缓解	BCR::ABL1 IS ≤0.01%（MR3 以下）口径按指南原文	GL-CN-2025
MMR	主要分子学缓解	BCR::ABL1 IS ≤0.1%，需同一实验室、IS 标化可比	GL-CN-2025
MR4	4 log 深度缓解	BCR::ABL1 IS ≤0.01% 且灵敏度足够	GL-CN-2025
MR4.5	4.5 log 深度缓解	BCR::ABL1 IS ≤0.0032% 且灵敏度达 MR4.5	GL-CN-2025
MR5	5 log 深度缓解	BCR::ABL1 IS ≤0.001%（需实验室支持）	GL-CN-2025

词表只给词义与来源版本，不做「是否达到」的判读。

复查记录（二级：录入 / 更正）

显式编辑 ≤1/页　记录者：家属代记

日期

2026-10-13

BCR::ABL1（IS%）

实验室 lab

IS 标化 is_std（1=是 / 0=否）

1

灵敏度 sens

MR4.5

单位 unit

IS%

保存（写入本机内存态）　改这一条（更正，不删除）　模拟候选被拒收

删除 = 更正：界面只出现「改这一条 / 更正」，历史版本同链可回溯。

本机新增的复查记录（0 条，内存态）

还没有本机新增记录；保存后这里会列出，并同步进趋势图与复诊资料包。

治疗路径（默认概要，按需展开细节）

阶段数 3　默认全部收起

● **确诊与一线起始** 2020–03–11 → 2021–06–30 确诊慢性期 CML（e13a2），开始伊马替尼 400 mg 每日 展开细节

方案

伊马替尼 400 mg · 每日 1 次 · 2020–03–15 → 2021–06–30

药名 / 剂量	伊马替尼 400 mg
频次	每日 1 次
起止	2020–03–15 → 2021–06–30
变更原因原文	“先减量，仍不耐受就换药” 来源：医生原话 · 血液科门诊 2021–05–08
凭据	骨髓 + 融合基因报告 2020–03–11（文件 B–D1）、门诊病历 2021–06–30（文件 B–D2）

指标和趋势

本阶段原始报告为 2020–03–11 骨髓与融合基因；qPCR 逐点抄录见分子线页

转录本	e13a2（典型）· RT–PCR 2020–03–11
染色体	Ph+（t9;22）· 骨髓细胞遗传学 2020–03–11
BCR::ABL1（IS%）	本原型数据集中该阶段无逐点 qPCR 抄录值

影像发现

无 · 说明：本阶段未做影像检查

影像报告	无
说明	确诊依据为骨髓 + 融合基因报告（B–D1）

副作用总结

1 条：皮疹 / 腹泻（处理原文已引）

2021–05–08 皮疹 / 腹泻	患者原话：“前臂皮疹，大便每天 3—4 次” 来源：家属代记（患者原话）
处理原文	“先减量，仍不耐受就换药” 来源：医生原话 · 血液科门诊 2021–05–08
凭据	门诊病历 2021–06–30（文件 B–D2）

心理与营养措施和效果

无措施记录 · 说明：该阶段未记录心理与营养措施

措施	无
效果（本人原话）	该阶段无记录
说明	无内容即写「无 + 说明」，不省略块

● **二线尼洛替尼** 2021–07–01 → 2026–04–09 因不耐受换尼洛替尼 300 mg 每日两次（空腹），维持至停药评估 展开细节

方案

尼洛替尼 300 mg · 每日 2 次 · 2021–07–01 → 2026–04–09

药名 / 剂量	尼洛替尼 300 mg
频次	每日 2 次（bid，空腹早晚各一次）
起止	2021–07–01 → 2026–04–09
变更原因原文	“伊马替尼皮疹腹泻不耐受，换尼洛替尼，空腹早晚各一次” 来源：医生原话 · 血液科门诊 2021–06–30
凭据	门诊病历 2021–06–30（文件 B–D2）

指标和趋势

2026–04–09 停药前最后 1 次 BCR::ABL1 IS 0.0028%

BCR::ABL1（IS%）	2026–04–09：0.0028%（市一院血液科 · IS 标化 · MR4.5）
DMR 持续时长	门诊记录 2026–04–09 记有「DMR 超过 2 年」（照抄门诊记录）
趋势一句话	逐点抄录；本页不连线判读，分段见分子线页

影像发现

无 · 说明：本阶段未做影像检查

影像报告	无
说明	本阶段文件为肝功能与门诊记录（B–D4、B–D5）

副作用总结

1 条：与肝功能相关的记录（报告原文已加引号照抄）

2025–11–20 报告原文	“肝功能异常（ALT 升高）” 来源：肝功能 2025–11–20.pdf 报告原文 · 文件 B–D4
患者原话	“ALT 62，没有不舒服” 来源：家属代记（患者原话）
处理原文	“尼洛替尼可能影响肝酶，加查一次” 来源：医生原话 · 血液科门诊 2025–11–20
等级	报告未给等级字段（本页不代拟等级）

心理与营养措施和效果

1 条家属记录

措施	每天早晚各一次服药（尼洛替尼需空腹）；不催她看报告（家属自述）
效果（家属代记原话）	“报告我先拍，等她愿意谈了再一起看；不催她” 来源：家属记录
说明	效果只照抄记录原话，不评疗效

● **TFR 停药尝试与密测** 2026-04-10 → 至今 按门诊评估进入停药尝试；停药后每 1–2 个月 1 次 qPCR，已完成 6 次

展开细节

方案

停药观察（无每日 TKI）· 2026-04-10 起

药名 / 剂量	（停药观察）· —
频次	无每日服药（none）
起止	2026-04-10 起
门诊记录原文	“DMR 超过 2 年、TKI 用了 6 年，达到书面条件，可以谈停药；停药后前半年每 1–2 个月抽一次” 来源：医生原话 · 血液科门诊 2026-04-09
凭据	TFR 评估门诊记录 2026-04-09（文件 B-D5）

指标和趋势

停药后 6 次 qPCR 逐点抄录：0.0028 → 0.0021（IS%）

BCR::ABL1（IS%）	2026-04-09：0.0028% → 2026-10-08：0.0021%（市一院血液科 · IS 标化 · MR4.5）
血常规（白细胞 10^9/L）	2026-04-09：5.6 → 2026-10-08：4.8
趋势一句话	逐点抄录，连线与分段见分子线页；本页不判读

影像发现

无 · 说明：停药密测期未做影像检查

影像报告	无
说明	本阶段文件为 qPCR 与血常规报告（B-D3、B-D6）

副作用总结

2 条停药相关记录（与停药日对齐）

2026-05-02 肌肉骨骼疼痛	患者原话：“停药后腰背和膝盖酸，早上明显” 来源：家属代记（患者原话）
2026-06-11 皮肤瘙痒	患者原话：“晚上痒，抓了会起红印” 来源：家属代记（患者原话）
处理原文	“停药综合征，多数几个月会缓解；影响生活可以来门诊” 来源：医生原话 · 血液科门诊 2026-05-08
对齐	两条均与停药日 2026-04-10 对齐显示（见副作用日志页）

心理与营养措施和效果

3 条患者原话记录（家属代记，含停药初期）

措施	停药后散步、瑜伽，避免熬夜（患者原话 · 家属代记）
效果（本人原话）	“好一点：两次报告都稳定，妈妈也不天天问了” 来源：患者原话 · 家属代记 2026-07-15

	“还行：就是等报告那三天难熬” 来源：患者原话 · 家属代记 2026-10-08 “紧张：停药第一周总觉得自己会复发，半夜会醒” 来源：患者原话 · 家属代记 2026-05-20
口径	患者原话按来源照抄（记录者为家属代记）；患者的担心原样保留在引号内，不是本页结论——本页不做判读（K1）

计划 vs 实际

阶段	计划	实际
2020-03-11 → 2021-06-30 · 确诊与一线起始	伊马替尼 400 mg 每日	“先减量，仍不耐受就换药” 来源：医生原话 · 血液科门诊 2021-05-08
2021-07-01 → 2026-04-09 · 二线尼洛替尼	尼洛替尼 300 mg 每日两次	“伊马替尼皮疹腹泻不耐受，换尼洛替尼，空腹早晚各一次” 来源：医生原话 · 血液科门诊 2021-06-30
2026-04-10 → 至今 · TFR 停药尝试与密测	停药观察（密测）	“DMR 超过 2 年、TKI 用了 6 年，达到书面条件，可以谈停药；停药后前半年每 1–2 个月抽一次” 来源：医生原话 · 血液科门诊 2026-04-09

口径说明：阶段按门诊记录 / 报告日期切分；「实际」只照抄处方变更线与门诊记录，不做推断。每阶段固定五块，缺内容写「无 + 说明」，不省略块。

TFR 准备（二级入口）

停药相关重大决策不 AI 生成、不出方向性措辞；本页只提供条件核对清单入口。

去 TFR 档案（条件核对清单 + 密测轨道）

本页 AI 协助

AI 协助（示例） · 按可比性分组

手工入口与二级页

二级页：复查记录 CML-LAB（血常规密测轨道 + 骨髓 / 细胞遗传学原文摘录）；资料导入（字段候选 → 逐项核对）；临床试验（M4 数据未接入）。

⋯ 更多→停药尝试准备